

Soplos funcionales y patológicos

1. Introducción y relevancia clínica

Un **soplo cardíaco** es un sonido adicional generado por el flujo turbulento de la sangre dentro del corazón o los grandes vasos.

En pediatría, **hasta el 50–70 % de los niños sanos pueden presentar soplos funcionales** en algún momento, especialmente entre los **3 y 7 años**.

El desafío clínico consiste en **distinguir un soplo funcional (no asociado a enfermedad estructural)** de uno **patológico (producido por una cardiopatía congénita o adquirida)**.

El **EUNACOM** suele presentar casos tipo:

“Niño de 5 años, asintomático, con soplo sistólico eyectivo grado II/VI en borde esternal izquierdo, sin otros hallazgos. ¿Conducta?”

□ **Respuesta:** observación y control, soplo funcional.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Soplos funcionales (inocentes)

- Ocurren por **turbulencia del flujo sanguíneo normal** sin lesión cardíaca.
- Asociados a **aumento del gasto cardíaco** (fiebre, anemia, ejercicio) o **características anatómicas** (pared torácica delgada).
- El flujo es **laminar**, sin gradiente patológico ni alteración hemodinámica.

b. Soplos patológicos

- Producidos por **alteraciones estructurales** del corazón o grandes vasos: comunicación anómala, estenosis, insuficiencia valvular o flujo acelerado anormal.
 - Implican **gradiente de presión anormal o regurgitación**.
 - Siempre deben evaluarse con **ecocardiografía Doppler**.
-

3. Clínica (características diferenciales)

A.

Soplos funcionales (inocentes)

Característica	Descripción típica
Intensidad	Suaves (grado I–II/VI)
Duración	Sistólicos (eyectivos), nunca diastólicos
Localización	Borde esternal izquierdo o foco pulmonar
Timbre	Musical, vibrante o soplante suave
Variación	Cambia con la posición: ↓ al ponerse de pie o durante Valsalva
Radiación	No se irradia
Síntomas	Niño asintomático, crecimiento normal
Otros hallazgos	Sin cianosis, sin soplos adicionales, sin signos de IC

☐ “Siete S” (en inglés): *Soft, Systolic, Short, Single, Small area, Sensitive to position, Symptomless.*

B.

Soplos patológicos

Característica	Descripción típica
Intensidad	≥ grado III/VI
Duración	Holosistólico o diastólico
Localización	Fija o inusual (apex, espalda, cuello)
Timbre	Áspero, de “máquina”, o retumbante
Radiación	Cuello, dorso o axila
Cambios con posición	No varía o aumenta en decúbito
Síntomas	Cianosis, disnea, taquipnea, pobre crecimiento
Otros hallazgos	Pulsos anormales, desdoblamiento fijo, frémito, hepatomegalia
☐ Todo soplo diastólico es patológico hasta demostrar lo contrario.	

4. Tipos de soplos funcionales más frecuentes en la infancia

Tipo de soplo	Edad típica	Características auscultatorias	Comentario

Soplo vibratorio de Still	3–6 años	Musical o vibrante, sistólico eyectivo grado II en borde esternal inferior	Más frecuente en la infancia. Desaparece al ponerse de pie.
Soplo pulmonar inocente	Escolar/adolescente	Sistólico eyectivo en foco pulmonar, suave, sin irradiación	Aumenta con fiebre o ansiedad.
Soplo venoso cervical	3–8 años	Continuo, audible en región supraclavicular, desaparece al girar la cabeza o en decúbito	Debe distinguirse del soplo de PCA.
Soplo carotídeo	Niños mayores	Sistólico eyectivo en cuello, desaparece con compresión carotídea	Asociado a flujo turbulento en arteria carótida.

Ninguno se asocia a signos de insuficiencia cardíaca ni cardiomegalia.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. No se requieren exámenes si:

- Soplo cumple criterios de inocencia.
- Niño asintomático, con examen físico normal y crecimiento adecuado.

b. Solicitar

ecocardiografía

si:

- Soplo diastólico, continuo o grado $\geq$ III/VI.
- Irradiación anormal.
- Presencia de cianosis, dificultad respiratoria o bajo peso.

- Soplo asociado a otros hallazgos: hepatomegalia, pulsos anormales, desdoblamiento fijo.

En Chile, la derivación prioritaria a **cardiología infantil** está normada por el **Programa de Salud del Niño (MINSAL)**.

6. Tratamiento y seguimiento

- **Soplos funcionales:** no requieren tratamiento, solo observación y tranquilidad a los padres.
 - Reevaluación en controles de salud infantil.
 - Desaparecen espontáneamente con el crecimiento.
- **Soplos patológicos:** manejo según causa específica (quirúrgico, farmacológico o intervencional).

☐ Evitar restringir actividad física en soplos funcionales. No requieren profilaxis de endocarditis.

7. Complicaciones y pronóstico

- **Soplos funcionales:** excelente pronóstico; desaparecen entre los 8–12 años.
 - **Soplos patológicos:** el pronóstico depende de la lesión subyacente; los shunts pequeños (CIV, CIA) pueden cerrar espontáneamente.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **El soplo de Still** es el más frecuente y benigno.
2. **Soplo diastólico = siempre patológico.**
3. Los **soplos funcionales cambian con la posición** (disminuyen de pie).

4. En soplo continuo, descartar **PCA** antes de atribuirlo a flujo venoso.
5. **Ecocardiografía solo si hay sospecha clínica de patología.**
6. Niño asintomático + soplo grado II/VI → control y educación familiar.
7. No todos los soplos requieren cardiología; el juicio clínico es clave.

□ Errores frecuentes:

- Indicar reposo o restricción sin motivo.
 - Pedir ecocardiograma a todos los niños con soplo.
 - Confundir soplo venoso cervical con PCA.
 - No tranquilizar adecuadamente a los padres.
 - Ignorar signos de alarma (diastólico, holosistólico, irradiado, síntomas).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La mayoría de los soplos en niños son funcionales (inocentes).
2. **Soplo sistólico suave, breve y variable con posición → funcional.**
3. **Soplo diastólico, continuo o $\geq$ III/VI → patológico.**
4. El **soplo de Still** es el más común, musical, sin irradiación.
5. **Ecocardiografía** solo si signos o características de patología.
6. **No restringir actividad ni indicar antibióticos profilácticos.**
7. Pronóstico excelente; suelen desaparecer espontáneamente.